

المخططات المعرفية اللاتكيفية وعلاقتها باضطراب الشخصية التجنبية لدي عينة من آباء وأمهات ذوي الإعاقة الحركية

إعداد

نورهان محمود عبدالحميد

باحثة ماجستير بقسم علم النفس

كلية الآداب، جامعة المنيا

mnono9533@gmail.com

إشراف

أ.م.د. أحمد سيد التلاوي

أستاذ علم النفس المساعد

كلية الآداب، جامعة المنيا

psych2010@yahoo.com

مستخلص البحث:

يهدف البحث الحالي عن الكشف عن العلاقة بين المخططات المعرفية اللاتكيفية وعلاقتها باضطرابات الشخصية التجنبية لدى آباء وأمهات ذوي الإعاقة وكذلك الفروق بين الآباء والأمهات في متغيرات الدراسة، وتكونت عينة الدراسة من (100) من آباء وأمهات ذوي الإعاقة الحركية منهما (50) من الآباء و(50) من الأمهات ،واستخدمت الباحثة مقياس المخططات المعرفية اللاتكيفية، اعداد يونج ، ومقياس اضطراب الشخصية التجنبية، اعداد الباحثة، وأشارت النتائج إلي وجود علاقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيًا عند مستوى (0.01) بين درجات آباء وأمهات الأبناء ذوي الإعاقة الحركية على مخطط(العيب / العار ، الإذعان/ الإنقياد) وبين اضطراب الشخصية التجنبية ، ووجود علاقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيًا عند مستوى (0.05) بين درجات آباء وأمهات الأبناء ذوي الإعاقة الحركية على مخطط(الهجر/ عدم الاستقرارالعزلة الاجتماعية / الوحدة) وبين اضطراب الشخصية التجنبية، كما يتضح عدم وجود علاقة ارتباطية بين درجات آباء وأمهات الأبناء ذوي الإعاقة الحركية على بعض المخططات المعرفية اللاتكيفية (الحرمان العاطفي، التشكك/ الإساءة الفشل، الاتكالية / الاعتمادية ، توهم الأذى أو المرض، التعلق/ هدم الذات ، التضحية

بالذات، الكبت العاطفي ، المعايير الصارمة / النفاق ، الاستحقاق / هوس العظمة ، العجز عن ضبط الذات) وبين اضطراب الشخصية التجنبية.

Astract

The current research aims to reveal the relationship between non-adaptive cognitive schemes and their relationship with avoidant personality disorders in families of people with disabilities, as well as the differences between parents in the study variables. The study sample consisted of (100) fathers and mothers, including (50) fathers and (50) mothers. The researcher used the non-adaptive cognitive schemes scale, the Young's number, and the avoidant personality disorder scale, and the researcher's numbers, and the results indicated a statistically functional positive correlation relationship at the level of (0.01) between the scores of parents of children with motor disabilities on a chart (defect / shame, obedience/obedience) and between avoidant personality disorder, and the existence of a statistically positive association relationship at the level of (0.05) between the scores and mothers of parents of children with motor disabilities on the chart (abandonment It is also clear that there is no correlation relationship between the scores of parents of children with motor disabilities on some non-adaptive cognitive schemes (emotional deprivation, skepticism/abuse, failure, dependence/dependence, illusion of harm or illness, attachment/self-destruction, self-sacrifice, emotional suppression, strict standards / hypocrisy, entitlement / mania, inability to self-control) and between avoidant personality disorder.

المقدمة :-

تعد الأسرة هي اللبنة الأولى لبناء المجتمع، وأن وجود طفل مصاب بداخلها تجربة مؤلمة عليها وعلي استقرارها، مما يجعلها تواجه الكثير من المشكلات والصعوبات والضغوط التي تفرضها طبيعة الحياة، وهو ما يؤدي الى توتر العلاقات الأسرية وأباء وأمهات الأطفال ذوي الإعاقة يواجهون درجة مرتفعة من الضغوط

والمشكلات الناجمة عن وجود طفل معاق في الأسرة حيث أن هذه الأسرة تبذل جهد كبير لتظهر الطفل بصورة مقبولة امام الناس وتهتم كثيراً برود افعال الآخرين لوجود طفل معاق لديهم (Ankeny, Wilkins & Spain, 2009) ولكي تستطيع الأسرة مواجهة التحديات التي فرضت بسبب وجود طفل من ذوي الإعاقة يجعلها في حاجة للمزيد من المساعدة والدعم في عدة جوانب وذلك بهدف تمكينها من مواجهة تلك الصعوبات بصورة إيجابية والاستفادة مما يقدمه المجتمع عبر مؤسساته من خدمات، ومما لا شك فيها أن قضية الإعاقة ليست قضية فردية بل هي قضية مجتمع بأكمله وتحتاج الى تعاون تام من جميع المؤسسات والقطاعات العامة والخاصة للتقليل من اثار الإعاقة السلبية (نادية أديب، صلاح الدين، ٢٠٠٤) والتي يمكن تنعكس علي شخصية المعاق وأسرته؛ فيعاني من بعض الاضطرابات النفسية والشخصية.

وتعد الشخصية التجنبية من أبرز اضطرابات الشخصية ويظهر فيها الشخص نمطا متكررا من التثبيط الاجتماعي، والشعور بعدم الكفاءة، وفرط الحساسية للتقييم السلبي، وتجنب الأنشطة المهنية التي تتضمن تواصلاً بين شخصين خوفاً من النقد والاستنكار والرفض من قبل الآخرين ويشعر الفرد المصاب بهذا الاضطراب بعدم الرغبة في الاندماج والانخراط مع غيره من الناس إلا مع من يحبهم فقط، ويبدو عليه ضبط النفس في إطار العلاقات الغريبة خشية الشعور بالخزي والنقد ودائماً ما ينشغل صاحب الشخصية التجنبية بالتعرض للنقد والرفض في المواقف الاجتماعية المختلفة، فينطوي ويتوقع على ذاته ويقل تقديره لذاته، ويرى أنه غير كفء وأقل شأنًا من غيره وأنه غير جذاب على الإطلاق، ويشعر بالرهبة من الإقدام نحو أي نشاط أو علاقة جديدة (روح الفؤاد محمد، ٢٠٠٦، ٣٠).

مشكلة الدراسة:

تعد تربية ورعاية الطفل جزء من المسؤولية التي تقع على عاتق الوالدين، ولكن هذه الرعاية تصبح مختلفة عندما يشخص الطفل بأن لديه إعاقة أو يحتاج إلى رعاية خاصة لمدة طويلة (Kwan, 2012) حيث أن ولادة طفل معاق تعد خبرة مؤلمة للأسرة

(Kumar,2008) مما قد يعرضها للوم الذات كنتيجة لولادة هذا الطفل فيكون مصدر خلل للوالدين وباقي أفراد الأسرة (Anthony,1991) أنهم يمرون بتغيرات كبيرة للتكيف مع وجود هذا الطفل المعاق داخل الأسرة حيث تتأثر بنية الأسرة بأربع طرق : إذ تنثير انفعالات قوية لدى الوالدين، وتعمل على تثبيط الهمة بسبب الشعور بالفشل المشترك وتعيد تنظيم الأسرة، وتخلق أرض خصبة للصراع (غزلان شمسي الدعي، 2009) كما أن والدي الطفل المعاق قد يظهر لديهم بعض الاضطرابات النفسية كالإكتئاب والقلق والانسحاب الاجتماعي وعدم احترام الذات، واضطرابات الشخصية المختلفة، واستجابة عالية للضغط تتعلق برعاية الطفل (Kerch, Hedvat, Hauser, Cram & Field, 2006) كما اشارت دراسات كل من (Ryan, Scott, Gregory, 2012; Nordah, 2006; Holhe, Haugum, 2005; Young & Brown, 1999).

ومن ناحية أخرى تلعب المخططات المعرفية اللاتكيفية دوراً هاماً في اضطراب الشخصية التجنبية، وأن المخططات المعرفية اللاتكيفية المبكرة ترتبط بمجموعة اضطرابات الشخصية من ووفقاً لرواد التوجه المعرفي في اضطرابات الشخصية فإن خبرات الطفولة للفرد تشكل مجموعة من المخططات المعرفية، وتحدد هذه المخططات الكيفية التي يدرك بها الفرد ذاته ومستقبله وعالمه الخارجي، فإذا كانت هذه المخططات مختلة وظيفياً أو غير تكيفية يترتب عليها سلوكيات وانفعالات غير تكيفية، ولهذا فإن وراء كل اضطراب من اضطرابات الشخصية بما فيها اضطراب الشخصية التجنبية معتقدات ومخططات لا تكيفية تؤدي إلى تشويه إدراك الفرد لما يرد إليه من معلومات، وتؤدي إلى استجابات انفعالية شديدة السلبية ، ونقص القدرة على حل المشكلات، وتعد الشخصية التجنبية من أبرز اضطرابات الشخصية ويظهر فيها الشخص نمطاً متكرراً من التثبيط الاجتماعي، والشعور بعدم الكفاءة، وفرط الحساسية للتقييم السلبي، وتجنب الأنشطة المهنية وحسب الدليل التشخيصي والإحصائي الرابع، فإن نسبة انتشاره كانت تتراوح بين (0.5-1.5) من المجتمع العام، ويتم تشخيص حوالي (10%) في العيادات الخارجية للصحة النفسية في حين وصلت هذه النسبة إلى (24%) من المجتمع العام حسب الدليل التشخيصي والإحصائي الخامس (Dsm-5,2013) أما الدليل

التشخيصي والإحصائي الرابع للاضطرابات النفسية والعقلية فقد وجد أنه أكثر شيوعاً بين النساء مقارنة بالرجال رغم أنه من المحتمل أن تكون النسبة متكافئة بين الجنسين (ناديه محمود غنيم، ٢٠١٧، ٢٣٢)

تساؤلات الدراسة:

- أ- هل توجد علاقة بين المخططات المعرفية اللاتكيفية واضطراب الشخصية التجنبية لدي عينة الدراسة؟
- ب- هل هناك فروق بين آباء وامهات الأطفال ذوي الإعاقة الحركية في المخططات المعرفية اللاتكيفية واضطراب الشخصية التجنبية؟

اهداف الدراسة:

- فحص العلاقة بين المخططات المعرفية اللاتكيفية واضطراب الشخصية لدى آباء وامهات الأطفال ذوي الإعاقة الحركية.
- الكشف عن الفروق بين آباء وامهات الأطفال ذوي الإعاقة الحركية في المخططات المعرفية اللاتكيفية واضطراب الشخصية التجنبية.

أهمية الدراسة: -

تتضح أهمية الدراسة الحالية من خلال عدد من النقاط التالية: -

- أهمية متغيرات الدراسة؛ حيث تناولت الدراسة الحالية مفهوم المخططات المعرفية اللاتكيفية المبكرة؛ حيث أن هذه المخططات تتشكل في مراحل مبكرة في حياة الفرد، وتؤثر سلباً على سلوكيات الأفراد وتؤدي هذه المخططات إلي بعض الأعراض المرضية كالقلق، والأكتئاب، واضطرابات الشخصية، وكذلك تناولت الدراسة الحالية مفهوم اضطرابات الشخصية وخصوصاً اضطراب الشخصية التجنبية؛ حيث أن هذا الموضوع يعد موضوعاً حيوياً وملموساً؛ فهذه الشخصية نجدها في واقع حياتنا.

- كذلك تقوم هذه الدراسة بأعداد مقياس لأضطرابات الشخصية التجنبية لدى آباء وأمهات ذوي الأعاقة
- ندره الدراسات العربية التي تناولت المخططات المعرفية اللاتكيفية المبكرة وعلاقتها بأضطراب الشخصية التجنبية.
- أن تسهم نتائج الدراسة في اعداد وتصميم برامج علاجية أو إرشادية للتخفيف من حدة وآثار اضطرابات الشخصية التجنبية من خلال العلاج بالمخططات المعرفية.

أولاً: المخططات المعرفية اللاتكيفية المبكرة

يعرفها يونج وآخرون بأنها أنماط معرفية وجدانية وانهزامية ، وافكار واسعة النطاق ومختلفة وظيفيا الى درجه كبيره تتعلق بالشخص وعلاقته بالآخرين وتتكون هذه المخططات من الذكريات والعواطف، والادراك والاحاسيس الجسديه، وهي تنشأ في مرحلة النمو الاولى ويستمر ظهورها طول فتره حياه الانسان، وتبدأ هذه المخططات كتوافق ايجابي نسبي مع بيئة الطفل ، ولكنها تتحول الى سوء تكيف عندما يكبر وكجزء من محاولة الانسان للتماسك تكافح المخططات للبقاء على قيد الحياه؛ حيث تؤثر تأثيرا كبيرا في تفكير الانسان وشعوره وتصرفاته وتواصله مع الآخرين (Young,et al 2003).

هي انساق ادراكية سلبية تقوم على هدم الذات وتتصل بالاستقرار ولكنها تعوق السلوك وتتشكل في الطفولة المبكرة في حياة الفرد نتيجة للعلاقات المضطربة بين الفرد وبين الأفراد في محيطه الاجتماعي، وهذه الخبرات السلبية تعمل على الإحباط ويستطيع الفرد اشباع حاجاته النفسية فيلجا الفرد الى ان اساليب لا تكيفية وهنا تظهر المشكلات الانفعالية والسلوكية وتستمر طوال حياة الفرد وتظل ثابت نسبيا في البناء النفسي للفرد وتتسم بمقاومته العالية للتغير إذا تعمل بشكل غيرواعي (احمد عبد الفتاح، هبه بهي، 2019:226).

خصائص المخططات المعرفية اللاتكيفية: -

- المخططات لا تركز فقط على الصدمات المعاشة أثناء الطفولة، بل هناك عوامل أخرى تكون سببا في تطورها، وتظهر المخططات خلال الطفولة والمراهقة، وتمثل بالفعل خصائص المحيط العائلي للطفل.
- وهي تعد حقائق أولية لدى الشخص حول نفسه والعالم.
- كما تعد حقائق مطلقة وأساسية وجوهرية، وغير قابلة للتعديل، أو التغيير إن تنشأ في سن مبكر وتصبح مألوفة (Young, 2005, 35)
- مختلفة وظيفيا الي حد كبير.
- منفصلة طوال حياة المرأة.
- وثيقة الصلة بالمستويات الانفعالية العليا أثناء نشاطها (صفوت فرج، 2008، 20،
- وتعد المخططات المعرفية اللاتكيفية هازمة للذات، ومدمرة متلفة وأغلبها ينجم عن الخبرات الضارة المؤذية التي تتكرر بشكل منتظم في زمن الطفولة والمراهقة.
- إنها ذاته مستويات مختلفة في الشدة والشيوع، فكلما زادت حدثها ازداد عدد المواقف التي تفعلها واشتدت حده المشاعر التي تولدها (Cummings, 2013)
- تنشط المخططات المعرفية نتيجة لتجارب الفرد وخبرات حياته السابقة، مثل علاقة الفرد بالأسرة والآخرين (محمد السيد، محمد سفان، 2015، 9)

النظريات المفسرة للمخططات المعرفية اللاتكيفية

توجد عدة نظريات تفسر تكوين المخططات المعرفية المبكرة اللاتكيفية منها:

1- نظرية جيفري يونج في المخططات المعرفية المبكرة اللاتكيفية:

تعد نظرية يونج في المخططات إلى حد كبير مع النظريات المعرفية الأخرى التي وضعها بيك وسيجال، فكل منها وصف المخططات المعرفية على أنها مركبات

ثابتة ومستمرة تنشأ مبكراً في الحياة، وتشكل مفهوم الفرد لذاته، وتؤثر في معالجة المعلومات التي ترتبط بالذات والبيئة المحيطة بالفرد، وتعد المخططات المعرفية المبكرة اللاتكيفية التي اقترحها يونج تطويراً لأفكار "بيك" حول التشوهات المعرفية، والاكتئاب، فهو يتضمن المسار الخطي الذي طوره في البداية من الخطوات المتتابعة الآتية:-

خبرات الطفولة السلبية مشكلات سلوكية / انفعالية، والمخططات هي أفكار محورية تتطور عبر الحياة تماثل معتقدات أنماط الحياة عند أدلر التي تؤثر في تفسير الفرد للأحداث، وهذه التفسيرات غالباً ما تصبح تلقائية، أي أنها تقفز المخططات أفكار تلقائية تفسيرات سلبية إلى ذهن الفرد مباشرة، دون وعي منه، وتشرح مدرسة المخططات المعرفية المبكرة وفقاً ليونج العلاقة بين خبرات الطفولة، والحالة المزاجية الفطرية لدى الفرد، والنتائج النفسية والاجتماعية والشخصية المترتبة على ذلك في مرحلتها المراهقة والرشد (Young,1999,23).

2- نظرية جان بياجيه:

تعتبر نظرية بياجيه في التطور المعرفي نظرية شاملة عن طبيعة الذكاء البشري وتطوره، واعتقد جان بياجيه أن مرحلة الطفولة لشخص ما دوراً حيوياً وفاعلاً في تنمية الشخص، وتعرف فكرة بياجيه في الأصل على أنها نظرية المرحلة التنموية، وتتعامل النظرية مع طبيعة المعرفة بحد ذاتها، وكيف يتقدم البشر تدريجياً في اكتسابها وبنائها واستخدامها، كما كان التطور المعرفي بنظر بياجيه إعادة تنظيم تصاعدي للعمليات العقلية الناتجة عن النضج الحيوي، والخبرات البيئية، واعتقد أن الأطفال يؤسسون فهماً وإدراكاً حول العالم المحيط بهم كما يؤسسون خبرات متباينة بين ما يعرفونه وما يكتشفونه في بيئتهم، ثم يعدلون أفكارهم وفقاً لذلك، وقد ادعى أيضاً بياجيه أن التطور المعرفي يكون في وسط الكائن البشري، وأن اللغة تتوقف على المعرفة، وأن الفهم يكتسب من خلال التطور المعرفي واقترح بياجيه نظرية التطور المعرفي التي تستخدم المخططات كأحد مكوناتها الرئيسية وعرف بياجيه المخططات كوحدات أساسية من المعرفة التي تتعلق بجميع جوانب العالم، تعتبر نظرية بياجيه في التطور المعرفي

نظرية شاملة عن طبيعة الذكاء البشري وتطوره، واعتقد جان بياجيه أن مرحلة الطفولة لشخص ما دوراً حيوياً وفعالاً في تنمية الشخص، وتعرف فكرة بياجيه في الأصل على أنها نظرية المرحلة التنموية، وتتعامل النظرية مع طبيعة المعرفة بحد ذاتها، وكيف يتقدم البشر تدريجياً في اكتسابها وبنائها واستخدامها، كما كان التطور المعرفي بنظر بياجيه إعادة تنظيم تصاعدي للعمليات العقلية الناتجة عن النضج الحيوي، والخبرات البيئية، واعتقد أن الأطفال يؤسسون فهماً وإدراكاً حول العالم المحيط بهم كما يؤسسون خبرات متباينة بين ما يعرفونه وما يكتشفونه في بيئتهم، ثم يعدلون أفكارهم وفقاً لذلك، وقد ادعى أيضاً بياجيه أن التطور المعرفي يكون في وسط الكائن البشري، وأن اللغة تتوقف على المعرفة، وأن الفهم يكتسب من خلال التطور المعرفي (Andrew, 2009, 50).

ثانياً: - اضطرابات الشخصية

- اضطراب الشخصية التجنبية:

يعرفها الدليل التشخيصي الإحصائي للاضطرابات النفسية: بأنها عبارة عن نمط سائد من الكف الاجتماعي، ومشاعر النقص، وفراط الحساسية للتقييم السلبي، وتظهر أعراض هذا الاضطراب من قبل سن البلوغ وحالياً تظهر في مجموعة متنوعة من السياقات (DSM_5, 2013, 65).

ويعرفها أحمد عبد اللطيف: بأنها شخصية تتجنب الاتصال بالآخرين، وتخشى إساءتهم وتقويمهم السلبي، لأن نقض الآخرين يؤدي أصحاب هذه الشخصية، وهي تتجنب الآخرين وأن لديها قلقاً اجتماعياً يجبرهم على تجنب الآخرين مع نقص في المهارات الاجتماعية (أحمد عبد اللطيف، 2010، 224).

- خصائص اضطراب الشخصية التجنبية:

يتصف الأشخاص ذوي اضطراب الشخصية التجنبية ببعض الخصائص سواء أدت هذه الخصائص إلى ظهور الاضطراب لديهم، أو أنهم اتصفوا بها بعد ظهور الاضطراب وهذه الخصائص هي:

- يعانون من انخفاض تقدير الذات والحالة المزاجية السلبية.
- يرغبون في إقامة العلاقات مع الآخرين ولكن خوفهم من الرفض يجبرهم على الوحدة.
- الانشغال بالتعرض للنقد أو الرفض في المواقف الاجتماعية، وإظهار التحفظ في العلاقات الحميمة.
- تجنب الأنشطة الجماعية التي تتضمن اتصال شخصي كبير بسبب الخوف من الانتقاد، أو الرفض، والتردد في المخاطرة أو القيام بأي انشطه جديده خوفا من التعرض للإحراج.

(Mosaic, 1999, 3:4)

- يتجنبون إقامة صداقات جديده ما لم يكونوا متأكدين من انهم سوف يتلقون الحب دون نقد.
- يتسم بعدم الجرأة في تأدية أعمال عادية خارج نطاق الأعمال الروتينية المعتادة، وقد يلغي مخططاً اجتماعياً لأنه يتوقع أن يصاب بالإعياء

(Dsm-5, 2013)

النظريات المفسرة للشخصية التجنبية: -

1- نظرية البنية المعرفية اللاتكيفية (الجيفري يونج):-

تقوم مبادئ هذه النظرية على أن الأفراد يطورون مخططات معرفية لاتكيفية مبكرة، استناداً إلى خبرتهم في الطفولة، تبدأ بخطأ في الوظيفة الإدراكية تؤدي إلى تكوين افتراضات ثم قناعات يتأثر بها الفرد، وتكون سبب في اضطرابات الشخصية، والقلق، والاكتئاب في سن البلوغ، ويقصد بالمخططات المعرفية اللاتكيفية الاستراتيجيات التي يقوم من خلالها الفرد بالتعامل مع المعلومات القادمة من المحيط الخارجي، وردود الفعل الموجهة نحو الذات (بتول بناي، ريام عبد المجسن، 2018).

2- نظرية العلاج المعرفي (ارون بيك):

تؤكد هذه النظرية على دور العمليات العقلية في الدوافع والانفعالات والسلوك ويعتبر الإدراك مفتاح المشاكل النفسية إذا يتم تحديد الاستجابات الانفعالية والسلوكية بناء على ادراك الفرد وتفسيره للمواقف المختلفة، فالاعتقادات الفكرية الخاطئة تقود الافتراضات ومفاهيم خاطئة والتي أطلق عليها بيك (التشوهات المعرفية) ويقوم الفرد بتبني هذه التشوهات المعرفية نحو نفسه والآخرين ويحدد سلوكه بناء عليها، فيظهر السلوك التجنبي هو الميل للعزلة، إضافة إلي مجموعة كبيرة من السلوكيات اللاتكيفية التي تسبب التوتر، والقلق الاكتئاب (Najaf, Lea Abramovich, 2024).

الدراسات السابقة: -

تناولت دراسة كوفيا وآخرون (Couveia et al (2006) المقارنة بين المخططات المعرفية اللا تكيفية المبكرة لدى مجموعة من ذوي الشخصية التجنبية ومجموعة من ذوي الرهاب الاجتماعي، وتكونت عينة الدراسة من (١٥٨) فرداً ثم تقسيمهم إلى ثلاث مجموعات تكونت المجموعة الأولى من (٦٢) من ذوي الرهاب الاجتماعي، والمجموعة الثانية من (٤١) من ذوي اضطراب الشخصية التجنبية (٥٥) مجموعة ضابطة، وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن ذوي الرهاب الاجتماعي يختلفون عن مرضى اضطراب الشخصية التجنبية في أحد مجالات المخططات المعرفية اللا تكيفية والمتمثل في الانفصال والرفض، ويتضمن المخططات الفرعية المتمثلة في: عدم الثقة والإساءة، الحرمان العاطفي، والعيب، العار الارتباطية بين المخططات المعرفية اللا تكيفية وأعراض اضطرابات الشخصية.

واجريت دراسة كار وفرانيسيس (Carr & Francis (2010) للتعرف على دور المخططات المعرفية اللاتكيفية المبكرة كمتغير وسيط بين التعرض للإساءة الانفعالية في الطفولة وأعراض الشخصية التجنبية ، وتكونت عينة الدراسة من (178) من مضطربي الشخصية، وتوصلت نتائج الدراسة إلى وجود ارتباط موجب بين مخططات السيطرة والكتب الانفعالي واضطراب الشخصية التجنبية، وأن التعرض لخبرات الإساءة الانفعالية في الطفولة ينبئ باضطرابات الشخصية التجنبية ، وأن المخططات المعرفية

اللاتكيفية المبكرة المرتبطة بالسيطرة والكبت الانفعالي عملاً كمتغير وسيط يؤدي دوراً مهماً في العلاقة بين التعرض لخبرات الإساءة في الطفولة وأعراض اضطراب الشخصية التجنبية.

دراسة نادية محمود غنيم عبد العزيز (2017) فقد هدفت إلى تعرف المخططات المعرفية اللاتكيفية واضطراب الشخصية التجنبية لدى طلاب الجامعة، وتكونت العينة من (405) طالب، وأظهرت النتائج وجود علاقة ارتباطية دالة بين المخططات المعرفية اللاتكيفية الاعتمادية، والعزلة الاجتماعية الوحيدة، والهجر وعدم الاستقرار، والعجز عن ضبط الذات، وتوهم الأذى أو المرض، والحرمان العاطفي، والإذعان أو الانقياد والكبت العاطفي، والعيب العار، التعلق بالآخرين / هدم الذات، والفشل التشكيك (الإساءة) وبين اضطراب الشخصية التجنبية.

أجرى كوفمان وآخرون (Kaufman,et.al 1990) دراسة استهدفت التعرف على المشكلات والضغوط النفسية التي يتعرض لها عينة من الآباء الذين يقومون برعاية أطفالهم المعاقين ذهنياً والتي تراوحت أعمارهم ما بين (20،41) عاماً وقد أجريت الدراسة على عينة مكونة من (57) أباً من آباء المعاقين ذهنياً ممن تراوحت أعمارهم ما بين (46،80) عاماً ، وأكدت نتائج الدراسة على وجود علاقة ارتباطية موجبة دالة إحصائياً بين الضغوط النفسية التي يتعرض لها الوالدان وبين كل من عمر الابن المعاق وحجم الأسرة والسلوك اللا توافقي الذي يعاني منه ويتسم به سلوك الابن المعاق.

حيث اجري عبد العزيز السرتاوي (1991) دراسة استهدفت التعرف على الآثار النفسية الناتجة عن إعاقة الطفل المعاق سمعياً على الوالدين، بالإضافة إلى معرفة الفروق بين آباء وأمهات الأطفال المعاقين سمعياً في ثلاثة مجالات هي الضغوط النفسية، التواصل مع الطفل المعاق سمعياً. والعلاقة مع المهنيين وغيرهم وتكونت عينة الدراسة من مجموعة من آباء وأمهات الأطفال المعاقين سمعياً. وأكدت النتائج على عدم وجود فروق دالة إحصائياً على استجابة الآباء والأمهات على الأبعاد الثلاثة. بالرغم من تعرض الآباء لضغوط نفسية Psychological Stresses أكثر

من الأمهات. وقد عبرت الأمهات عن ثقتهم في قدرتهن على التواصل مع طفلهن المعاق سمعياً، ولم تكشف النتائج عن وجود أثر الجنس الطفل على استجابات الوالدين تجاه طفلهن المعاق سمعياً.

فروض الدراسة

- توجد علاقة دالة إحصائية بين المخططات المعرفية اللاتكيفية واضطراب الشخصية التجنبية لدى عينة الدراسة.
- توجد فروق دالة إحصائية بين آباء وأمهات الأطفال ذوي الإعاقة الحركية في المخططات المعرفية اللاتكيفية واضطراب الشخصية التجنبية.

منهج وإجراءات الدراسة

أولاً - منهج الدراسة:

اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي، لانة المنهج الملائم لتحقيق اهداف الدراسة والتحقق من صدق الفروض.

ثانياً -عينة الدراسة:

تكونت العينة من (100) من آباء وأمهات الأطفال ذوي الإعاقة الحركية، (50) أب، (50) أم، تتراوح أعمارهم ما بين (35 : 45) عام، وجميعهم من محافظة المنيا.

ثالثاً - أدوات الدراسة:

أ- مقياس المخططات المعرفية اللاتكيفية: إعداد يونج: (تعريب وتقنين/ عبد الرحمن وسعفان، 2015)

- الخصائص السيكمترية للمقياس:

قام بترجمة هذا المقياس عبدالرحمن وسعفان (2015) ، وتم التحقق من الخصائص السيكمترية على عينة قوامها (350) من طلاب الدبلوم العام وذلك بحساب الاتساق الداخلي للمقياس ، وأوضحت النتائج ارتباط جميع العبارات بالأبعاد التي تنتمي إليها ، ثم التحقق من صدق المقياس باستخدام التحليل العاملي الاستكشافي

مما أثبت تمتع المقياس بدرجة عالية من الصدق ، كما تم التحقق من ثبات المقياس فوجد أنه يتمتع بدرجة جيدة من الثبات بطريقة ألفا كرونباخ حيث تراوحت معاملات الثبات من (0.6 - 0.8) ، وتكون الإجابة على المقياس بطريقة ليكرت السباعي متدرجة من

لا ينطبق تماماً (1) ، لا ينطبق غالباً (2)، لا ينطبق تقريباً (3)، معتدل (4)، ينطبق تقريباً (5)، ينطبق غالباً (6)، ينطبق تماماً (7)، وتشير الدرجة المرتفعة إلى وجود المخطط .

3- الخصائص السيكمترية لمقياس المخططات المعرفية اللاتكيفية في الدراسة الحالية:

حساب مؤشرات الاتساق الداخلي: من خلال حساب معامل ارتباط درجة كل عبارة والدرجة الكلية للمخطط الذي تنتمي إليه العبارة وكانت جميع العبارات ذات دلالة إحصائية عند مستوى (0,05,0,01).

ثبات المقياس

تم حساب معامل ثبات المقياس من خلال طريقة الفا كرونباخ وكذلك جميع معاملات الثبات تتراوح ما بين (0,61:0,74) وهي مؤشرات مرتفعة لثبات المقياس.

2- مقياس اضطراب الشخصية التجنبية: إعداد (الباحثة)

يتكون المقياس من (15) عبارة، ويتم الإجابة عليها في ضوء عدد من الاختيارات وهي: - دائماً=4، أحياناً=3 ، نادراً=2، أبداً=1 وتتراوح الدرجات ما بين (15:60) درجة (أ) صدق الاتساق الداخلي: -

حساب معامل ارتباط درجة كل عبارة والدرجة الكلية لمقياس اضطراب الشخصية التجنبية ، وكانت معاملات الارتباط تتراوح ما بين (0,315,0,648) وكانت جميعها دالاً عند مستوى (0,01,0,05).

(ب) صدق المحكمين: -

تم عرض المقياس علي عدد من المختصين في مجال علم النفس، وتم الاتفاق علي العبارات التي وصلت نسبة الاتقان عليها (75%) وأكثر.

(ج) ثبات مقياس اضطراب الشخصية التجنبية: -

تم حساب ثبات المقياس من خلال طريقة ألفا كرونباخ فكانت (0,81) وهو معامل ثبات مرتفع

نتائج الدراسة وتفسيرها:-**أ- نتائج الفرض الأول وتفسيرها.**

ينص هذا الفرض على أنه توجد علاقة ذات دلالة أحصائية بين المخططات المعرفية وأضطراب الشخصية التجنبية لدي عينة الدراسة.

وللتحقق من صحة هذا الفرض تم حساب معامل الارتباط الخطي لبيرسون Pearson correlation coefficient بين درجات أفراد عينة الدراسة من آباء وأمّهات ذوي الإعاقة على مقياس المخططات المعرفية اللاتكيفية ومقياس اضطرابات الشخصية التجنبية كما هو موضح بجدول (1)

جدول رقم (1)

معاملات الارتباط الخطية لبيرسون بين عينة الدراسة من آباء وأمّهات ذوي الإعاقة على مقياس المخططات المعرفية اللاتكيفية ومقياس اضطراب الشخصية التجنبية
(ن=100)

اضطراب الشخصية التجنبية	المتغيرات
**0.337	الحرمان العاطفي
**0.169	الهجر / عدم الاستقرار
**0.249	التشكك/ الإساءة
**0.277	العزلة الاجتماعية/ الوحدة
**0.325	العيوب / العار
**0.301	الفشل
0.052	الانكسالية/ الاعتمادية
**0.187	توهم الأذى أو المرض
0.024-	التعلق/هدم الذات
**0.289	الإذعان/ الانقياد
*0.131-	التضحية بالذات
0.105	الكبت العاطفي
*0.137-	المعايير الصارمة/النفاق
0.108	الاستحقاق/هوس العظمة
**0.154	العجز عن ضبط الذات

**معامل الارتباط دال عند مستوى دلالة 0.01 * معامل الارتباط دال عند مستوى 0.05

- بالنسبة للعلاقة الارتباطية بين المخططات المعرفية واضطراب الشخصية التجنبية لعينة آباء وأمهات الأبناء ذوي الإعاقة الحركية :-

يتضح من الجدول السابق وجود علاقة ارتباطية موجبة دالة إحصائياً عند مستوى (0.01) بين درجات آباء وأمهات الأبناء ذوي الإعاقة الحركية على

مخطط(العيب / العار ، الإذعان/ الإنقياد) وبين اضطراب الشخصية التجنبية ، ووجود علاقة ارتباطية موجبة دالة إحصائياً عند مستوى (0.05) بين درجات آباء وأمهات الأبناء ذوي الإعاقة الحركية على مخطط(الهجر/ عدم الاستقرار ، العزلة الاجتماعية / الوحدة) وبين اضطراب الشخصية التجنبية ، كما يتضح عدم وجود علاقة ارتباطية بين درجات آباء وأمهات الأبناء ذوي الإعاقة الحركية على بعض المخططات المعرفية اللاتكيفية (الحرمان العاطفي، التشكك/ الإساءة ، الفشل، الاتكالية / الاعتمادية ، توهم الأذى أو المرض، التعلق/ هدم الذات ، التضحية بالذات ، الكبت العاطفي ، المعايير الصارمة / النفاق ، الاستحقاق / هوس العظمة ، العجز عن ضبط الذات) وبين اضطراب الشخصية التجنبية.

وبذلك يتحقق الفرض بشكل جزئي، ويتفق ذلك مع نتائج دراسة كلاً من (عبد العزيز، 2017 ، نادية محمود غنيم، 2017) حيث أظهرت النتائج وجود علاقة ارتباطية دالة بين المخططات المعرفية اللاتكيفية واضطراب الشخصية التجنبية في(مخطط العزلة الاجتماعية، والهجر وعدم الاستقرار، وتوهم المرض)

كما أن هذه النتائج تختلف مما توصلت إليه دراسة (Carr&Francis, 2010, Kunst, 2020) وتري الباحثة أن هذا الاختلاف يرجع إلي اختلاف عينه الدراسة حيث أظهرت نتائج الدراسة وجود علاقة ارتباطية دالة بين جميع المخططات المعرفية اللاتكيفية ما عدا مخطط التعلق وعدم النضج ومخطط الأذى والمرض.

كذلك تفسر الباحثة هذه النتائج في ضوء الإطار النظري حيث ان غالباً ما يبدأ السلوك التجنبي في مرحلة الرضاعة أو الطفولة ، ويظهر ذلك في شكل الخجل والعزلة

والخوف من الغرباء في المواقف الجديدة، وبالرغم من أن الخجل في الطفولة يعتبر مؤشرا شائعا لدى الأطفال، فإنه يختفي تدريجيا عند معظم الأشخاص مع التقدم في العمر، أما الأفراد الذين يعانون من اضطراب الشخصية التجنبية، فيمكن أن يتزايد خجلهم وتجنبهم أثناء المراهقة وبداية مرحلة الرشد، عندما تصبح العلاقات الاجتماعية مع الأشخاص الجدد ذات أهمية خاصة، لذا فإن هذا التشخيص يجب أن يستخدم بحذر كبير بين الأطفال الذين يمكن أن يعتبر قلقهم وخجلهم شيئا طبيعيا بالنسبة لمرحلة النمو (DSM-5، 2012، 675)

كما ترى الباحثة أن هذه النتائج ترتبط بحجم الضغوط التي يتعرض لها آباء وامهات ذوي الإعاقة وما تسببه من اضطرابات نفسية ومشكلات سلوكية كبيرة تنعكس على شخصياتهم، تعد تربية ورعاية الطفل جزء من المسؤولية التي تقع على عاتق الوالدين، ولكن هذه الرعاية تصبح مختلفة جدا عندما يشخص الطفل بأن لديه إعاقة أو يحتاج إلى رعاية خاصة لمدة طويلة حيث أن ولادة طفل معاق يُعد خبرة أو حدث مؤلم للأسرة مما قد يعرضها للوم كنتيجة، لولادة هذا الطفل فيكون مصدر خجل للوالدين وباقي أفراد الأسرة؛ حيث أنهم يمرون بتغيرات كبيرة للتكيف مع وجود هذا الطفل المعاق فوجود طفل معاق يؤثر على بنية الأسرة بأربع طرق: إذ تثير انفعالات قوية لدى الوالدين، وتعمل على تثبيط الهمة بسبب الشعور بالفشل المشترك، وتعيد تنظيم الأسرة، وتخلق أرض خصبة للصراع كما أن والدي الطفل المعاق قد تظهر لديهم بعض الاضطرابات النفسية كالإكتئاب والقلق والانسحاب الاجتماعي وعدم احترام الذات واستجابة عالية لضغط تتعلق برعاية الطفل والرعاية التربوية للطفل المعاق قد تسبب ضغوط كبيرة على الوالدين؛ حيث أشار إلى أن رعاية الطفل المعاق ليست بالمهمة السهلة والبسيطة على الأسرة فوجوده يعرضها للمجموعة متعددة من الضغوط النفسية تتعلق بنوع ودرجة إعاقة

الطفل وفي هذا الصدد تشير البحوث التي تناولت الضغوط النفسية لدى آباء وأمهات الأطفال المعاقين إلى أن هناك درجة عالية من الضغوط لديهم مقارنة بوالدي الأطفال غير المعاقين .

ت - نتيجة الفرض الثاني وتفسيرها:

" توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين آباء وأمهات ذوي الإعاقة في المخططات المعرفية اللاتكيفية واضطرابات الشخصية وفقا للنوع.

وللتحقق من صحة هذا الفرض، تم استخدام اختبار "ت" لعينتين مستقلتين Independent Sample Test لمعرفة دلالة الفرق على مقياس المخططات المعرفية اللاتكيفية تبعاً لمتغير النوع (أب - أم)، ويوضح جدول (2) نتائج هذا الفرض.

جدول (2)

المتوسطات والانحرافات المعيارية ودلالاتها للفروق بين متوسطى درجات آباء وأمهات ذوي الإعاقة على المخططات المعرفية اللاتكيفية واضطرابات الشخصية تبعاً للنوع

مستوى الدلالة	قيمة " ت "	أم (ن = 152)		أب (ن = 148)		العينة المتغيرات
		ع	م	ع	م	
غير دالة	0.134	8.11	15.88	6.94	15.99	الحرمان العاطفي
غير دالة	0.665	7.92	18.82	7.32	18.24	الهجر / عدم الاستقرار
غير دالة	1.2	6.72	16.9	6.06	16	التشكك / الإساءة
غير دالة	0.38	7.88	17	6.9	16.67	العزلة الاجتماعية/ الوحدة
غير دالة	1.46	6.1	10.64	6.11	11.67	الغيب / العار
غير دالة	0.63	6.65	13.36	6.66	13.85	الفضل
غير دالة	0.95	6.86	13.64	6.29	14.37	الاحتكالية/ الاعتمادية
غير دالة	0.25	6.83	17.34	6.13	17.16	توهم الأذى أو المرض

التعلق/هدم الذات	17.66	6.77	18.21	7.96	0.63	غير دالة
الإذعان/ الانقياد	14.62	6.14	12.83	7.38	2.28	دالة عند 0.05
التضحية بالذات	21.25	8.91	22.58	7.55	1.4	غير دالة
الكبت العاطفي	17.08	5.92	19.11	6.44	2.84	دالة عند 0.01
المعايير الصارمة/النفاق	21.58	9.1	24.79	8.4	3.17	دالة عند 0.01
الاستحقاق/هوس العظمة	17.82	6.88	17.96	7.25	0.17	غير دالة
العجز عن ضبط الذات	17.67	6.47	18.4	6.93	0.93	غير دالة
اضطراب الشخصية الاعتمادية	29.17	5.79	28.71	7.43	0.6	غير دالة
اضطراب الشخصية التجنبية	34.35	8.08	33.6	8.41	0.78	غير دالة

بالنسبة للفروق في اضطراب الشخصية التجنبية تبعاً للنوع :

يتضح من جدول (2) أنه لا يوجد فرق دال إحصائياً بين متوسطي آباء وأمهات ذوي الإعاقة في اضطراب الشخصية التجنبية

أوضحت الدراسة عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطي آباء وامهات ذوي الإعاقة في اضطراب الشخصية التجنبية، وتري الباحثة أن هذه الفروق بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة (نادية محمود، 2017 ، غالب محمد، زينب محمد، 2016، Dressen, 1990) وتوصلت نتائج الدراسات إلي وجود فروق ذات دلالة إحصائية في اضطراب الشخصية التجنبية بين الذكور والاناث لصالح الاناث، وتري الباحثة أن هذا الاختلاف يرجع إلي طبيعة العينة حيث استخدمت الدراسات عينه طلاب الجامعة بينما استخدمت الدراسة الحالية آباء وامهات ذوي الإعاقة

كذلك تفسر الباحثة هذه النتائج في ضوء الإطار النظري حيث ان نظرية ادلر يري أن أسلوب الاجتماعي والأسلوب المسيطر واسلوب الأخذ، والأسلوب المتجنب والتجنبية تعني محاولات الفرد لتجنب المواقف الضاغطة، أو التقليل الانفعال باستجابات سلوكية معينة كالأكل والشرب وغيرها، ويلجأ الفرد لهذا الأسلوب نتيجة لإحساسه بعدم الجدوى من المقاومة أو اليأس من نتيجة المواقف الضاغطة أو المشكلة و يعتقد ادلر بأننا من أجل ان نفهم شخصية الفرد وطبيعة الأسلوب المتجنب علينا ان

نراقب المواقف التي يتبناها الفرد عندما يواجه مشكلة معينة، وقد يكون لهذا الأسلوب صفه الدوام والثبات نوعا ما على امتداد حياة الفرد، أن الأفراد ذوي الشخصية التجنبية هم الأشخاص الذين لا يقومون بأي محاولة لمواجهة مشاكل الحياة خوفا من الفشل، أو الإخفاق، ولا يتوفر لديهم اهتمام اجتماعي، ولا نشاط يكفي ليشاركها أو يخاطروا في أي مسلك من مسالك الحياة، وإن هدف التفوق لديهم هو أن ينجحوا في تجنب جميع المشكلات، ولا يعرضون أنفسهم لا دنى المخاطر، وهكذا تجنبوا الفشل (Ziegler et al, 1980:24).

حيث تري الباحثة أن عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطي أباء وأمهات ذوي الإعاقة يرجع إلي أن ذوي اضطراب الشخصية التجنبية يرغبون في إقامة علاقات مع الآخرين ولكن خوفهم من الرفض يجبرهم علي الوحدة وتري الباحثة انه لا يوجد فروق لان الإباء والامهات لأن كلاهما يعيشوا نفس الشعور ونفس الخوف والرفض مما حولهم، فهما يخنفوا من المواقف بسبب الخوف من ان يكون رد الفعل من الآخرين اهانه او رفض.

المراجع

أولاً: - المراجع باللغة العربية

- أحمد عبد الفتاح عياد، هبه بهي الدين ربيع. (2019). علم النفس المرضى تدريبات إكلينيكية ميدانية. طنطا، مركز الكتاب الجامعي.
- أحمد عبد اللطيف أبو أسعد. (2010). علم نفس الشخصية. الأردن، عالم الكتب الحديث، ط1.
- بتول بناي زبيري، ريام عبد الحسين عبد الله. (2018). البني المعرفية اللاتكيفية لدي طلبة الجامعة. مجلة جامعة بابل للعلوم الإنسانية، 26(9)، 1-7.
- روح الفؤاد محمد إبراهيم. (٢٠٠٦). اضطرابات الشخصية وعلاقتها بالإساءة للمرأة في العلاقات الزوجية والعمل. رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة الزقازيق.
- شمسي محمد الدعدي. (2009). الضغوط النفسية والتوافق الأسري و الزوجي لدى عينة من أبناء وأمهات الأطفال المعاقين تبعاً لنوع و درجة الإعاقة و بعض المتغيرات الديموغرافية والاجتماعية. رسالة ماجستير منشورة، كلية التربية، جامعة أم القري.
- صفوت فرج. (2008). القياس النفسي. القاهرة: دار الفكر العربي.
- محمد السيد عبد الرحمن، محمد أحمد ابراهيم سغفان. (٢٠١٥). مقياس المخططات المعرفية اللاتكيفية. القاهرة، دار الكتاب الحديث.
- نادية محمود غنيم عبد العزيز. (2017). المخططات المعرفية اللاتكيفية كمتغير وسيط بين الخبرات النفسية في الطفولة واضطراب الشخصية التجنبية لدي طلاب الجامعة. مجلة كلية التربية ، جامعة الأزهر، 36، (175) ، 299-306.

- ناديه أديب بامية، أحمد صلاح الدين أبو الحسن. (٢٠٠٤). دور مؤسسات المجتمع لدعم قضايا رعاية وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، المؤتمر العربي الدولي.

ثانياً: - المراجع الاجنبية

- American Psychiatric Association. (2000). Diagnostic and statistical manual of mental disorders. *Text revision*.
- Andrews, G., Halford, G. S., Murphy, K., & Knox, K. (2009). Integration of weight and distance information in young children: The role of relational complexity. *Cognitive development*, 24(1), 49-60.
- Ankeny, E. M., Wilkins, J., & Spain, J. (2009). Mothers' experiences of transition planning for their children with disabilities. *Teaching Exceptional Children*, 41(6), 28-36.
- Anthony, C., (1991). *Stress of Parents with Autistic Children, Dissertation of Social work*, University of Hong Kong.
- Cummings, J. A., Hayes, A. M., Cohen, L. H., Laurenceau, J. P., Saint, D. S., & Gricol, K. (2013). Interpersonal competence and daily stress generation in individuals with avoidant personality disorder symptoms. *Journal of Social and Clinical Psychology*, 32(2), 135-158.
- Kersh, J., Hedvat, T. T., Hauser-Cram, P., & Warfield, M. E. (2006). The contribution of marital quality to the well-being of parents of children with developmental disabilities. *Journal of intellectual disability research*, 50(12), 883-893.
- Kumar, R. (2018). *Research methodology: A step-by-step guide for beginners*.
- Kwan, M. Y., Cairney, J., Faulkner, G. E., & Pullenayegum, E. E. (2012). Physical activity and other health-risk behaviors during the transition into early adulthood: a longitudinal cohort study. *American journal of preventive medicine*, 42(1), 14-20.

- Mosack, M. A. (1999). *A structural study of avoidant personality disorder: The role of evaluation* (Doctoral dissertation, Duquesne University).
- Najafi, T., & Lea-Baranovich, D. (2014). Theoretical background, therapeutic process, therapeutic relationship, and therapeutic techniques of REBT and CT; and some parallels and dissimilarities between the two approaches. *International Journal of Education and Research*, 2(2), 1-12.
- Nordahl, H. M., Holthe, H., & Haugum, J. A. (2005). Early maladaptive schemas in patients with or without personality disorders: Does schema modification predict symptomatic relief?. *Clinical Psychology & Psychotherapy*, 12(2), 142-149.
- Shorey, R. C., Stuart, G. L., & Anderson, S. (2013). Differences in early maladaptive schemas in a sample of alcohol-and opioid-dependent women: Do schemas vary across disorders?. *Addiction research & theory*, 21(2), 132-140.
- Young, J. E. (1999). *Cognitive therapy for personality disorders: A schema-focused approach*. Professional Resource Press/Professional Resource Exchange.
- Young, J. E., Klosko, J. S., & Weishaar, M. E. (2005). *Schemagerichte therapie: Handboek voor therapeuten* [Schemafocused therapy: Manual for therapists]. Houten, The Netherlands: Bohn Stafleu Van Loghum.
- Young, J. E., Klosko, J. S., & Weishaar, M. E. (2006). *Schema therapy: A practitioner's guide*. guilford press.